Diskussion 1312

Datum: 1915-05-21
Kammare: Andra kammaren
Antal yttranden: 6
Källa: Tal om Kvinnor: Annotated Corpus (doi:10.5281/zenodo.18211787), byggd på The Swedish Parliament Corpus (Yrjänäinen m.fl. 2024).

Markerade ord: ¹ kvinna-ord, ² släktskaps- och tilltalsord, ³ yrkestitlar.

1. unknown (–, –)

Herr talman! Jag vill blott nämna, att jag sedan 32 år varit en mycket noggrann observatör i vac-

vaccinationens verkningar och de olägenheter, som den fört med sig. Vid ett tillfälle blev jag av kommunalstämman utsedd att hålla animal vaccin för vaccinering, och då användes intet annat än animal vaccin. Därvid blevo de flesta mycket svårt sjuka. Ett äkta par svävade mellan liv och död, mannen blev aldrig frisk och är nu död, **hustrun²** lever men är ännu ej frisk. Min mening och tanke är den, att de fingo sin sjukdom genom vaccinationen. Vaccinatören där hemma är en gammal man, som blivit både medaljör och annat på grund av sitt vaccinerande, men från den dagen avstod han från att vara vaccinatör.

z Jag får för min del instämma med dem som yrka avslag på förslaget.

2. Gunnar Löwegren (Socialdemokraterna, man)

Herr talman, mina herrar! Jag skall be att få börja med den rent personliga bekännelsen att, då jag insattes i utskottet, var jag fullständigt odeciderad i min ståndpunkt till vaccinationsfrågan, och om jag lutade åt någon linje, var det väl snarast åt den, att vi skulle i någon mån försöka befria de enskilda från tvånget, försöka att i denna fråga giva den enskilde viss bestämmanderätt.

Det första vi då i utskottet togo oss före var naturligtvis att bilda oss en uppfattning om vad nyttan och vad den möjliga skadan av vaccinationen kunde vara. Det är genom studier i den saken jag blivit fullständigt bestämd i min åsikt. Jag har nämligen kommit till den alldeles bestämda åsikten, att det är högst sällan som man kan påvisa någon verklig skada av vaccineringen. Däremot är det otvivelaktigt, att vaccinering är av största betydelse till förhindrande av en sjukdom, vilken visst icke, såsom exempelvis herr Bernhard Eriksson sökt göra gällande, är en sjukdom i utdöende, en sjukdom, som icke behöver fruktas, utan som mycket lätt kan komma över till oss, om vi icke vidtaga alla de åtgärder, som erfordras för att hålla den på avstånd.

Denna uppfattning har jag fått väsentligen genom studiet av statistiken i frågan, ty som herrarna kanske ha sig bekant, är det uteslutande med statistiskt material, som man överhuvud taget kan bevisa något för eller emot i denna fråga. Detta statistiska material är då

dels att hänföra till den officiella stati- Sen och dels till speciella undersökningar av enskilda forskare.

Vad man först av allt lägger märke till, är att den agitation i antivaccinatorisk riktning, som förekommer överallt ute i landet, bedrives just med tillhjälp av en massa statistiska uppgifter. Denna agitation har otvivelaktigt en mycket stor verkan, och jag tvekar icke att säga, att den opinion mot vaccinationen, som finnes i vårt land, till större delen bygger just på de upp-

gifter, som man hämtat i pastor Vallbergs skrifter, »Ögon- Ang. lag om diagnostikern» och andra. skyddskopp"

Nästan genomgående påstås uti den, att de och de siffrorna äro hämtade ur den och den officiella publikationen. Men tar man och slår upp denna officiella publikation och jämför siffrorna där med de siffror, som finnas i dessa böcker, så står man häpen och söker förgäves efter siffrorna, ty de finnas i de flesta fall icke alls i de officiella publikationer, som man hänvisar till.

Jag skulle kunna framdraga massor av exempel härpå, men jag skall bara ta ett exempel från den sista tiden. När det talas om att dödligheten på grund av koppor ökats högst väsentligt i Tyskland under detta århundrade, och när man för denna sakens skull just i »Ögondiagnostikern» börjar med talet 54 för att till slut komma upp till — jag tror — siffran 114, så är det en fullständigt missvisande siffra, och det hela alldeles oriktigt. Överhuvud taget är dödligheten genomgående mycket högre än dessa siffror utvisa, men den har icke något anmärkningsvärt höjt sig under senaste period. Stegringen som enligt »Ögondiagnostikern» skulle uppgå till en fördubbling, finnes icke alls i verkligheten. Tvärtom är det så, att om man räknar med relationssiffror, skulle det vara en genomgående sänkning även i Tyskland.

Ett annat exempel, som jag kan taga ur högen, — det står till och med i den motion, som är avgiven här i kammaren. Det påstås, att Tyskland på de senaste åren varit ogynnsammare ställt med avseende på koppdödligheten än England. Man frågar sig med förvåning, varifrån en sådan sifferuppgift kan härstamma. Det talas om de tio senaste åren. Ja, för de allra senaste åren föreligger icke någon tillräckligt utarbetad statistik, men för de sista år, från vilka man har uppgifter, är det nära nog alldeles samma siffror i Tyskland som i England. Tager man då den sista tioårsperiod, som man kan hålla sig till, visar det sig, att det i England blir 1,2 dödsfall per 100,000 invånare, men 0,034 dödsfall i Tyskland. Detta innebär som herrarna själva kunna se, att dödligheten i koppor är mer än trettio gånger så stor i England än i Tyskland. — Och ändå finner man i motionen uppgifter i fullkomligt motsatt riktning!

Det står för resten i en skrift, som vi på allra sista tiden. fått mottaga från pastor Vallberg, något om att sedan man infört vaccinationstvång 1 Italien ha förhållandena där försämrats, och det är alltjämt 10,000 dödsfall per år i det landet. Nu bör förutskickas att än i denna stund

är vaccinationen mycket dåligt genomförd i detta land. Men för att bevisa, hur den likvisst haft en högst väsentlig nytta och medfört en stark sänkning i dödstalen och att det ingalunda varit några 10,000 dödsfall per år,

kan jag nämna, att för åren 1889—1892, d. v. s. perioden före vaccinationslagens införande, funnosi genomsnitt 6,133 dödsfall i Italien, men sedan har denna siffra sjunkit till 1,946 under nästa femårsperiod, för att under perioden 1899—1903 återigen gå upp något, nämligen till 2,477, medan siffran under den sista period, för vilken man har siffror tillgängliga, sjunkit till 951(!).

Jag bör väl också taga fasta på de uppgifter om koppdödligheten, som stå i en av motionärerna omnämnd statistik, vilken är tagen från staden Minden och som hänför sig till, tror jag, året 1874 eller 1875. Där har gjorts en indelning i åldersklasser, och man har anfört procenttalen för späda barn och för övriga barn intill tio års ålder. Där finnas tabeller, som se ganska obehagliga ut, ty enligt dem skulle det vara en ganska stark dödlighet bland de vaccinerade. Men dessa exempel, som anföras ännu i dag, ha för långliga tider sedan avskrivits från den vederhäftiga litteraturen 1 frågan.

På 80-talet tillsattes som bekant en stor rikskommission i Tyskland, vilken skulle sysselsätta sig med vaccinationsstatistiken. Den tog även till behandlingen denna statistik från Minden, som från början är framlagd av en tysk läkare vid namn Böing. Denna rikskommission kom ganska snart underfund med alt en massa av dessa uppgifter från 70-talet från Minden och andra städer vid Rhen voro fullständigt missvisande, på grund av att själva primärmaterialet hopsamlats på ett mycket otillfredsställande sätt. Det visade sig nämligen, att i dessa städer kring Rhen var det icke läkare, som, då ett dödsfall i koppar ägt rum, konstaterat, huruvida den döde varit vaccinerad eller ej, utan uppgifterna hade insamlats genom att poliser, som gingo omkring och frågade föräldrar, målsmän och släktingar, om den döde varit vaccinerad. Därvid svarades genomgående, att den döde varit vaccinerad, ty annars blevo de efterlevande straffade med 20 Marks böter. Och som det naturligtvis icke var någon människa, som gärna ville betala 20 Mark i böter, svarades det naturligtvis merendels, att den döde varit vaccinerad. Det är på detta sätt man fått denna statistik, som naturligtvis icke äger någon som helst beviskraft.

Man har emellertid även kommit med medvetet falska sifferuppgifter, då det gällt framförande av bevismaterial mot vaccinationen.

Jag kan i det fallet icke underlåta att taga fasta på Keller, vilkens statistik länge varit ett starkt bevismaterial i den antivaccinatoriska litteraturen. Keller var cheföverläkare för de österrikiska järnvägarna och således en man med mycket stort anseende, men han var redan från tidiga år bekant som en mycket fanalisk antivaccinatör. Han insamlade uppgifter om dödligheten i koppor från alla järnvägstjänstemän i Österrike och indelade de döde i vaccinerade och ovaccinerade. Denna statistik visade, att man dog väsentligt mer i koppor,

om man var vaccinerad, än om man var ovaccinerad. I åratal har man begagnat sig av

denna statistik, och ingen människa vågade på länge betvivla dessa uppgifter, bakom vilka det stod en sådan bekant vetenskaplig auktoritet.

Så hände sig emellertid i mitten på 80-talet att den världsbekante statistikern, doktor Körösi, en av den moderna statistikens allra mest framstående målsmän, började betvivla dessa uppgifter. Körösi sökte få fast på själva primäruppgifterna,

. V. S. de rapporter, från de olika Järnvägsläkarna, på vilka Keller byggt sin statistik, men det visade sig då, att detta material fullständigt saknades i Järnvägsarkivet 1 Wien. Körösi skickade då ut frågelistor till de olika järnvägsläkarna, som ännu voro i livet, och bad, att om de hade kopior av de rapporter, som de en gång i tiden skickat in till Keller, skulle de sända dem till Körösi. Han fick sådana konceptrapporter från ett ganska stort antal läkare och kunde därigenom jämföra talen på kopielistorna med talen på de listor, som avtryckts av Keller. Det visade sig då mycket snabbt, att det knappt var en enda siffra, som stämde, utan att Keller företagit en systematisk korrigering av talen för att de skulle kunna uppvisa resultat, som voro förmånliga för antivaccinationisterna. Körösi hade dock icke det faktiska beviset för att här förelåg annat än ett missförstånd eller en misstolkning och därför ville han icke direkt beskylla Keller för förfalskning. Men några år därefter kom Kellers efterträdare i ämbetet att sysselsätta sig med samma sak, och i ett gammalt skåp fann han verkligen de ursprungliga listorna, som en gång använts av Keller. Han fann då till sin förvåning, att dessa listor först voro skrivna med bläck och sedan överskrivna med blåkrita. Bläcksiffrorna stämde tydligt med siffrorna i kopiorna i de fall, där sådana kunnat erhållas från distriktsläkarna, men de siffror, som voro ditskrivna med blåkrita, stämde med Kellers tal. Det var i sanning en systematisk »korrigering» av ursprungstalen, som Keller företagit!

Jag har så utförligt gått in på detta, därför att man från anlivaccinationens sida påstått, att det föreligger bedrägeri från deras sida, som äro anhängare av principen om tvångsvaccinering. Det var icke länge sedan vi här i andra kammaren av antivaccinatörer fingo ett litet brevkort satt i våra händer, vilket var undertecknat av en tysk professor eller titulärprofessor, och där stod, att det var bevisat, att en hel del av de uppgifter, som; lämnats till den tyska rikskommissionen, varit byggda på medveten lögn eller något dylikt, jag kommer icke precis ihag ordalydelsen. Och ständigt finner man hur vaccinationens anhängare beskyllas för att bedriva medveten förfalskning. Jag tror att man med fullt fog kan vända om den beskyllningen och säga, att de, som bedriva förfalskningar härvidlag, det är autivaccinatörerna. Ty det finnes knappast en enda verkligt bärrande statistisk uppgift bland dem de komma med, vilken talar mot vaccinationen, och när de söka draga fram sådana uppgifter, som synas logiskt tala mot vaccinationen, kan man knappast i

ett enda fall få dessa uppgifter bestyrkta av de officiella rapporterna.

För övrigt slår naturligtvis den antivaccinatoriska riktningen över till det rent absurda, varpå redan framhållits exempel från statsrådsbänken. Jag skall endast berätta om ett enda litet uttalande, som icke alls är gjort i överilning utan med full behärskning och eftertanke. Det är en professor Wittinger, som gått mycket grundligt tillrätta med vaccinationen, och han påstår, att vaccinationen är det största brott, som är begånget under det sista århundradet. Och en fransman, som arbetat mycket på detta område, hans namn är de Lisle, låter sin aversion mot vaccinationen kulminera, när han kommer med det mycket lustiga påståendet, att vaccinationen bidrager till närsynthet och skallighet, till en pessemistisk världsåskådning och till fiendskap mot skön konst och litteratur.

Jag har tyvärr inte tid att nu ytterligare gå in på ett skärskådande av antivaccinationslitteraturen. Det kunde emellertid framdragas oerhört många exempel på hur pass ovederhäftig den är. Men som motsats till denna statistik skall jag be att få framhålla, att ehuru den statistik, som framlägges till förmån för vaccinationen, naturligtvis icke i var enda punkt är fullt korrekt. Och icke heller är efter strängaste metodologiska regler absolut beviskraftig, den dock är ett kraftigt bevismaterial för vaccinationen. Det finnes också, som utskottet har framhållit, vissa enstaka undersökningar, vilka äro gjorda efter de strängaste metodologiska regler. Man har från allra senaste åren en sådan undersökning från Metz, man har en tidigare från Budapest, och dessa visa med all önskvärd tydlighet just vad utskottet framhållit, nämligen att risken att insjukna i koppor är ungefär 4, 5 gånger större, då man är ovaccinerad, än då man är vaccinerad. Och vad beträffar dem, som drabbas av sjukdomen, är dödlighetsrisken ungefär 6 gånger så stor bland de ovaccinerade som bland de vaccinerade. Jag tror inte, att man behöver mera talande siffror för att förstå, vilken oerhörd betydelse det har för ett folk att ha : fått undergå en väl genomförd vaccinering. Och för att bara ta några mer gripbara siffror, som var och en strax kan förstå innebörden av, skall jag något litet vidröra den statistik, som är hämtad från olika länders arméer. Den torde vara mycket beviskraftig, därför att uppgifternas korrekthet icke kan bestridas, och vidare därför, att man där har material från en och samma ålder, då de undersökta ju äro genomgående av samma åldersklass, vidare därför att man år från år kan följa dessa uppgifter, så att man kan precis beräkna, hur mycket förbättringar i hygieniska förhållanden kunnat spela in det ena eller andra året. Det är sålunda en statistik, som jag tror kan anses vara synnerligen beviskraftig, och närhelst man gär till denna statistik, finner man, i Tyskland, Österrike, Frankrike eller vilket annat land som helst, att i och med att vaccinationen genomföres, sjunker kroppssjukligheten

och dödligheten i alldeles häpnadsväckande grad. I Tyskland genomfördes vaccination bland militären året 1835. Före det året rådde en dödlighet på 100,000, som uppgick år 1834 till 28, år 1833 till 75, år 1832 till 36,70. I och med att vaccinationen var genomförd, sjunker dödligheten till sådana tal som 3,5, 2,4, 3,5, 1,6 och så vidare, det vill säga, den sjönk till en obetydlighet mot vad den hade varit förut. Och då sedermera efter fransktyska kriget revaccinationen införts — det vill säga, då hade soldaterna först som barn blivit ympade och blevo sedan revaccinerade, då de började sin militära tjänstgöring — finna vi, att dödligheten i

tyska armén sjönk till 0. Det är enstaka år, som det kan vara ett enda dödsfall, men under de sista trettio åren tror jag — har icke något enda dödsfall i smittkoppor ägt rum inom tyska armén. Det är väl ändå ett bevis, så kraftigt man kan tänka sig, så väl för vaccinationens som för revaccinationens värde. Och samma erfarenheter komma sedermera fram, vare sig man tar den ena eller andra armén. Man har infört vaccination och revaccination i franska armén, i österrikiska armén och överallt" har man nått samma lyckliga resultat.

Men jag bör kanske i detta sammanhang påpeka, att man icke skall tro, att man bara därför att man är vaccinerad, är skyddad för varje koppsjuklighet eller för koppdödlighet. VWVaccinationen är icke något absolut skydd, utan den innebär blott en oändligt stark minskning i risken att bli sjuk eller som insjuknad att dö i sjukdomen. Denna risk är minst under de första åren efter vaccineringen och ökas sedermera, så att efter 9, 10 år skyddet delvis är hävt, men sedermera kan revaccinationen i ännu högre grad, än vad som varit fallet med vaccinationen, skydda för sjuklighet och dödlighet.

Det har från visst håll framförts den synpunkten, att vårt land är så lyckligt ställt, att vi troligen icke behöva skydda oss för koppsjukdomarna. 'Jag vill svara därpå, att det är en mycket vacker förhoppning, som därmed uttalas, men en förhoppning, som mycket lätt kan komma på skam. Man har icke något som helst bevis för att vi under kommande tider verkligen skola kunna gå så fria från koppsjukdomen, som vi varit under allra senaste åren. Och det förtjänar i det avseendet påpekas, att man på 1850-, 60-talet här hemma i vårt land, trots att man då hade betydligt fler smittkoppsfall, än vi nu haft under de allra senaste åren, hade gått och invaggat sig i den tron: »vi få naturligtvis icke någon farligare koppepidemi mer». Därför avtog vaccinationen högst väsentligt, i synnerhet i en sådan stad som Stockholm, vilken enligt förste stadsläkarens berättelse var synnerligen dåligt vaccinerad på 1870-talets början. Men vad inträffade? Jo, att vi i samband med den allmänna cpidemi, som gick över Europa efter det fransk-tyska krigets slut, fingo smittan hit över till Sverige, och just i huvudstaden, där befolkningen var i liten utsträckning vaccinerad, fanns en så utomordentlig härd för spridning av koppsmittan, att man på mycket

elakartade epidemier, som Europa haft att uppvisa under sista århundradet. Det dog bara under året 1874 4,063 personer och under 1875 2,119, och det var först genom en starkt ökad vaccinering, som man äntligen lyckades få bukt på denna epidemi. Sedan dess har vårt land lyckligtvis varit befriat från nya epidemier, men om vi icke vidtaga alla möjliga försiktighetsåtgärder, vem vågar då ta på sitt ansvar att garantera, att vi icke när som heist kunna få en ny sådan förhärjande epidemi, vilken det vill jag understryka, väsentligen härjar bland barn, och som skulle komma att nu, då åldersgränsen för barnen är framflyttad till 6 år, betydligt starkare härja än på 1870-talet, då ännu 2-årsåldern var den allmänna.

Man invänder kanske, att när en sådan epidemi kommer, då kan man vidtaga alla möjliga försiktighetsåtgärder. Ja, jag hörde nyss ett uttryck, som lär vara vanligt i arbetarkretsar och som jag tyckte vara mycket tillämpligt på vad herr Bernhard Eriksson anförde. Det heter: »Det

är så dags att be till Gud, när Hin står i farstun.» Ha vi fått en epidemi in i vårt land, är det svårt att begränsa den, så framt icke tidigare en god vaccinering varit genomförd. Vi få nämligen tänka på den omständigheten, att en person kan gå 10, 14 dagar med koppsmitta, utan att någon människa kan konstatera det. Tänk då, om här i Stockholm omkring ett 10-tal personer gå omkring med dylik koppsmitta bland en i stort sett ovaccinerad befolkning. Hur oändligt snabbt kan icke denna smitta sprida sig vidare och vidare, och när man äntligen börjar vaccinera, ja, då har man försuttit tiden, och då ha vi icke möjlighet att vaccinera tillräckligt snabbt, och även om, vad läkare enhälligt förneka, man skulle på en gång, på några dar, hinna med en vaccinering av en hel stad sådan som Stockholm, måste man räkna med att det vid första ympningen är en massa personer, som vaccinen inte biter på, en stor mängd, som därför skulle behöva vänta månader för att kunna bli koppade på nytt med resultat. Hur vill man över huvud taget skydda dessa personer från risken att drabbas av en dylik smitta? Det är sålunda alltid en stor del av befolkningen, som under sådana förhållanden löper risk att bliva nedsmittad.

Man skall inte härvidlag komma och tala om, att man har vissa isoleringsmöjligheter, att man kan upprätta sjukhus o. d.; ty den metoden har hittills inte på ett enda ställe visat sig effektiv. Man har försökt med isolering i vissa städer i England, särskilt i Leicester och Gloucester. Men vad har visat sig? Jo, att det har visat sig, att i dessa städer gå epidemierna alideles förträffligt, och märkvärdigt nog har man inte kunnat märka, att i de familjer, där isolering ägt rum eller från vilka man fört insjuknade till sjukhus med detsamma, smittan icke spritt sig lika väl, som där isolering icke vidtagits. Ingen vill förneka möjligheten av att delvis, till en liten grad, hämma sjuk-

domen genom isolering, men man kan ännu omöjligen konstatera, i hur stor utsträckning en dylik isolering kan vara av verkan och betydelse, och läkarna stå därvidlag på den ståndpunkten, att de icke veta, hur smittan överföres från koppsjuka till icke sjuka. Man har ännu inte lyckats bakteriologiskt påvisa smittämnet, och under sådana förhållanden kan var och en lätt begripa, att det är oändligt svårt att vidtaga effektiva isoleringsätgärder. När smittämnet en gång är upptäckt, och man begriper, hur smittan överföres, då kan man möjligen slå in på en vägen, men att redan nu göra det, är ett vågsamt experiment, och jag skulle inte gärna vilja se, att vårt folk bleve försökskanin på det området, ty det kunde hända att vi finge sona det med 5 å 6,000 dödsfall.

Man talar också om, att hela det nuvarande förslaget är så oändligt strängt i sina bestämmelser. Ja, jag tycker, att skall man verkligen bekämpa en sjukdom med ett medel, om vars effektivitet man är övertygad, skall man genomföra detta bekämpande konsekvent och icke låta några luckor stå kvar på ena eller andra området. En sådan omständighet, som att t. ex. bevärringsmännen bli revaccinerade, tycker jag för min del är uteslutande till förslagets fördel, och det kan inte framdras som någonting, som våldför sig på den personliga friheten, ty är man så gammal och stark, som en beväringsman är, kan man sannerligen underkasta sig det ganska obetydliga obehag med en ympning.

Jag vill i detta sammanhang framhålla, att det där talet om att ympningen medför så oändligt mycken skada är fullständigt överdrivet. I de fall, där man kunnat göra en undersökning av, huruvida någon skada uppkommit av ympningen eller icke, har man genomgående funnit, att det i nästan nio tiondedelar av de anförda fallen varit oriktiga uppgifter. I det avseendet bör erinras om, att antivaccinatörerna agitera icke minst genom att skildra, hurusom många tiotusentals människor dött på grund av vaccineringen, och hurusom många blivit fördärvade för hela sitt liv genom följdsjukdomar. De förse ofta sina berättelser med fotografiska bilder. Jag tänker just på en av dessa fotografiska bilder, vilken mera än de flesta andra rört tyskarnas sinnen, den finnes visst i Wegeners Impfriedhof. Den visar ett litet barn, på sin dödsbädd med en krans av rosor runt omkring huvudet, en rörande bild, vilken skall visa ett offer för koppsjukdomen. Ja, tyska medicinalstyrelsen har låtit undersöka även detta fall och det har befunnits, att **flickan²** dog av lunginflammation, och att **hon²** samtidigt haft hjärnhinneinflammation. Ingen lär väl kunna tro, att vaccineringen lett till, att detta barn avlidit i dessa två sjukdomar!

På samma sätt är det genomgående, när man tar fasta på de olika fallen: det icke kan ledas i bevis, att vaccineringen åstadkommit döden. I Tyskland har man varit så noggrann, att man genomgått miljoner fall, och man har icke kunnat finna nå-

Reservanterna vilja nu införa en samvetsklausul i lagen, och man har därvid resonerat som så, att man skulle antaga utskottets förslag i övrigt, men att denna samvetsklausul vore nödvändig, för att minska opposition mot lagen ute i landet. Jag antydde i början av mitt anförande, att jag själv något reflekterat på den vägen, ty jag begrep, att det kunde ligga en stor agitatorisk kraft däri, att en del av de mest intensiva motståndarna till vaccinationen skulle slippa att låta vaccinera sina barn. Agitationen mot vaccinationen skulle troligtvis därigenom minskas i häftighet. .

När det gällde att få en form för denna samvetsklausul, så att icke alla möjliga personer skulle kunna befrias från vaccinationstvånget av enbart lättjeskäl, stod jag emellertid ohulpen, och kunde icke finna någon formulering för denna samvetsklausul, som öppnade möjlighet till befrielse för de verkligt samvetsömme, och stängde av den möjligheten för dem, som över huvud icke hade någon uppfattning 1 frågan.

I samband härmed vill jag säga, att då man talar om de olika uppfattningarna i vaccinationsfrågan, räknar jag icke med den grupp, som herr Bernhard Eriksson ansåg vara den största i Sverige, nämligen den grupp, som överhuvud icke satt sig in i vaccinatiorsfrågan, utan blott dömde efter allmänna talesätt, sedan den läst igenom första bästa skrift av en ögondiagnostiker. Jag anser icke sådana personer kompetenta att bedöma frågan och de ha icke någon samvetsömhet i hithörande avseende, utan det är blott godtycke de följa om de säga sig vara emot vaccinationen. Dessa personer vill jag ha frånskilda, om man över huvud skall ha en samvetsklausul. Men hur skall man formulera en sådan

bestämmelse, genom vilken de icke komma med? Den klausul, som är formulerad av herrar Vennerström och Hult, ger största möjlighet för var och en, som vill slippa ifrån vaccinationstvånget, att bli befriad. Under sådana förhållanden är det för mig absolut omöjligt att gå med på deras förslag. Nu säger man, att det i England finnes en sådan samvetsklausul. Men man bör komma ihåg, att vaccinationsåldern i England icke är satt så sent som till sex år. Vidare är det engelska folket synnerligen vant att röra sig med förpliktelser på heder och samvete. Herr Vennerström vet säkert, att man kan gifta sig i England utan att behöva förete några papper. Man behöver icke ha intyg om när man är född eller vem man är eller om man varit gift förut, utan det har ingått i det vanliga rättsmedvetandet till den grad i England, att då man avgiver en försäkran på tro och heder, så skall denna vara absolut riktig, annars ådrar man sig mycket sträng straffpåföljd. Det var därför bara ett nytt fall av en gammal känd sak, som kom till, då man lät samvetsklausulen i förevarande fall bero på avgivandet av en försäkran på heder och samvete.

Men är vårt folk vant att avgiva dylika förbindelser? Stick till första bästa man, som aldrig vidare hört talas om vaccina-

tionen, en intygsblankett! Tror någon, att han tar saken på all-

var, då han skall underteckna denna eller inför prästen intyga, att han är samvetsöm? Jag vill icke nedsätta hans heder, den kan vara lika stark som någon annans, men jag tror icke, att man i allmänhet skall anse det ligga något betydelsefullt i ett sådant intyg på heder och samvete i vaccinationsfrågan, utan i många fall kommer säkerligen underskriften eller påståendet inför prästen att avgöras utan större samvetsömhet. Jag tror sålunda icke, att det ingått i svenskt rättsmedvetande att avge dylika förbindelser på heder och samvete.

I ett sådant land som England har det emellertid blivit ett sorgligt resultat av samvetsklausulens tillämpning. Under de senare åren har antalet av dem, som använt klausulen, ständigt ökats, så att det från att under 1890-talet och in på första delen av detta århundrades första decennium ha utgjort 9 99 nu gått upp till 35 9o. Därtill kommer, att i nästan alla länder 10 9/9 av dem, som borde ympas, på grund av slarv hålla sig undan. Man har därför i England kommit till det resultat, att år 1913 tack vare samvetsklausulen och genom slarv 45 9/9 av dem, som borde vaccinerats, hållit sig undan. Kan någon mena, att det blir effektivitet i en tvångslagstiftning, som innehåller en samvetsklausul, medelst vilken inemot halva antalet slipper igenom ? Och jag är övertygad om, att om vi här i Sverige skulle gå denna väg, bleve resultatet, att det icke stannade vid de 45 9/0.

Jag vill till slut betona, att det här gäller en samhällsangelägenhet av allra största räckvidd. Det är ett verkligt intresse att smitta icke sprides. Vaccinering är icke en individuell angelägenhet, ty den, som icke låter vaccinera sig, utsätter icke blott sig själv för smitta utan ökar möjligheten för andra att bli nedsmittade. Här föreligger sålunda ett stort och viktigt statsintresse, och för min personliga del ställer jag mig givetvis på den ståndpunkten, att

brytes ett stort statsintresse med ett individuellt, — vilket i detta fallet understundom är förenat med stor samvetsömhet, men i de flesta fall icke är det — tvekar jag icke i valet, utan anser, att det individuella intresset bör vika. Det är samhällsintresset, statsintresset, som i första rummet skall bevakas. I det sammanhanget bör påpekas, att en av dem, som i Tyskland på 1870-talet ivrigast arbetade för vaccinationslagen, var Bebel. .

Vårt land var tack vare framsynte män, ett av de första, som införde vaccinationstvång. Det vore skam och skada, om vi hundra år senare skulle borttaga det, därför att det rörts upp en storm, som till största delen kommer från ovederhäftigt håll.

3. Arvid Lindman (Högerns riksdagsgrupp, man)

Det lär vara nödvändigt för var och en att sätta sig in i denna fråga, och det är så mycket angelägnare, när man hör hur meningarna här bryta sig mot varandra. Den fråga jag skulle vilja göra är denna: är nyttan av vaccinationen övervägande den skada, som eventuellt kan uppkomma därav? Man kan, synes det mig, omöjligt studera handlingarna i denna fråga utan att komma till den bestämda uppfattningen, att nyttan är så vida övervägande skadan, att man ovillkorligen måste erkänna den saken. Det var en ledamot av kammaren, som nyss frågade mig, vad vi veta om detta, då vi endast läst utskottets betänkande, och vad vi över huvud känna om saken och vad som gör, att vi kunna bilda oss någon ståndpunkt i frågan. För mig ställer sig saken så, att jag tror på vetenskapen, då den förklarar, att ympningen är till nytta och att den motverkar spridningen av den smittosamma sjukdomen. Det är andra, som icke tro på denna vetenskap, men jag ville då fråga, varför vi ha vetenskapsmän och varför vi låta personer studera sådana saker som den nu förevarande, om vi icke bry oss om de resultat, vilka studierna leda till? Det är visserligen sant, att man kallar detta för tro på auktoriteter. Till viss grad måste man tro på auktoriteter, och i detta fall är det fullkomligt vetenskapligt bevisat, att vaccination är till skydd mot smittkopporna, så att någon tvekan icke bör kunna råda härom. Statistiken utgör också en vetenskap. Varför skola vi icke tro på den? Dess uppgifter äro i allmänhet mycket objektiva, och den uppfattning man bibringas av statistikens siffror går otvetydigt i den riktningen, att ympning varit till stor nytta. Man talar emellertid om, att den också kan medföra skada. Då det är nödvändigt, att vi begränsa oss i debatten, skall jag härvidlag inskränka mig till att hänvisa till vad herr civilministern framhållit i sitt anförande och vad vi för övrigt kunna se i utskottets handlingar, att vaccination icke är farlig blott man ser till, att ympämnet är av den rätta beskaffenheten, och att ympningen sker på rätta sättet. Av statistiken framgår också, att det endast är i ett utomordentligt minimalt antal fall, där verkligen någon skada kunnat påvisas, och där ympning medfört förlust av människoliv. Jag anser för min del, att dessa fakta äro avgörande för att man bör följa utskottet i denna del, och att det skulle vara obskurantism att icke vilja rätta sig efter vetenskapen i ett dylikt fall.

Här har anförts av en talare, att om man nu genom lag bestämmer, att man skall göra skyddskoppymtrningen obligatorisk, så kan man riskera, att vetenskapsmännen komma och hitta på att ympning skall ske mot andra sjukdomar också. Ja, jag skulle vilja säga för min del, att i den mån vetenskapen skrider framåt och i den mån det därigenom blir möjligt att

åstadkomma ympning mot andra sjukdomar, så måste man betrakta detta som en stor välgärning mot mänskligheten. Ympning mot smittkoppor har varit en välgärning mot mänskligheten och en välgärning mot befolkningen i vårt land. Kunde man nu ha samma möjlighet att skydda sig mot andra sjukdomar, ja, då vore väl detta en ytterligare väl-

gärning mot mänskligheten, såvitt jag kan förstå. En mycket framstående läkare berättade för mig härom dagen — och Jag åberopar sålunda här hans uttalande — att de tyska soldaterna blivit

ympade mot fyra olika sjukdomar. Det kommer därför att visa sig av den erfarenhet man fått efter kriget, att sjukdomsfallen i den tyska hären äro ofantligt mycket färre än i de andra stridande arméerna. Det är väl en lycka, mina herrar, att något sådant kan åstadkommas.

Jag kommer slutligen till en fråga, som vidröres i reservationen till $ 2, nämligen om övertygelsen och dess betydelse härvidlag. Om man känner sig övertygad om skyddskoppympningens skadlighet, så skulle man få vägra att låta ympa sina barn. Ja, där ställer jag mig inte på den uppfattnigen, ty jag har den meningen, att man har i ett sådant fall icke rätt att vägra, bara därför att man anser, att det kan vara skadligt. Ty det är dock så, att den, som vägrar i detta fall att begagna sig av medlet, han kan visserligen åstadkomma skada för sig själv eller för sina egna barn, men han kan även härigenom åstadkomma olycka för andra och det i än större omfattning, och det är det jag förmenar att han icke borde ha rätt att göra. Därför menar jag, att lagen bör kunna tvinga till det, när det anses att det är nyttigt. »ÅAtt vara övertygad om skadligheten» — ja, kunna herrarna säga mig, huru många av vårt folk, som satt sig in i denna fråga, så att de verkligen kunna säga, att de äro övertygade om skadligheten? Den första bästa antivaccinatör, som det kallas, som kommer och viskar i örat på en person, att detta skall han låta bli, ty det medför de och de följderna — och så kommer han med alla dessa svartmålningar, som pläga anföras ja, då blir personen ifråga övertygad och kan sålunda bara av denna anledning säga, att han vägrar att vaccinera sina barn, ty nu är han övertygad om att det är skadligt. Nej, mina herrar, i ett lagligt samhälle bör det icke och får det icke efter min uppfattning vara så, det kan ej få bero på individen, om denna vill eller icke vill underlåta något som kan vara avgjort skadligt eller nyttigt för samhället och för samhällets befolkning.

Så till sist endast ett ord, herr talman, beträffande läget sådant detta just nu är. Man säger, att om frihet kunde beredas dem, som icke tro på nyttan, så skulle det bli lättare att få lagen igenom. Ja, kunde man tänka sig, att denna frihet begagnades i mycket liten utsträckning, så skulle ej så stor skada vara skedd. Men, man får tänka på en sak, vilken redan förut blivit framhållen: är det ej just nu, som faran kan vara i antågande, är det ej just efter detta stora pågående olycksaliga krig, som faran för smittkoppor kommer att göra sig gällande? Och denna fara kommer ju närmast från Ryssland, där denna siukdom redan grasserar, och den lär dessutom finnas ft. o. m. 1 Finland. Skola vi sitta här och med öppna ögon låta bli att antaga en lag, som kan bereda oss effektivt skydd mot denna fara och i stället endast vänta på att

den smittosamma sjukdomen skall komma in i vårt land kanske till obotlig skada, ja, till död och fördärv för många människor? Nej. mina herrar,

det vill jag för min del icke vara med om, att vi skola göra, att vi skola sitta här och taga emot en så ovälkommen gäst som denna sjukdom, om den kommer hit, och därför anser jag, att man måste rösta för denna lag, till vilken jag sålunda, herr talman, ber att få yrka bifall.

4. Axel Schotte (Liberala samlingspartiet, man)

Herr talman! Endast några ord i denna redan så omdebatterade fråga, rörande vilken jag tror, att de flesta skäl för de olika ståndpunkterna redan blivit framlagda. Det är emellertid några synpunkter, som jag tror icke blivit tillräckligt berörda, och jag skall därför be att få särskilt fästa mig vid dem.

Herr Bernhard Eriksson i Grängesberg sade, att denna lag erbjuder stora fördelar i jämförelse med nu gällande förhållanden. Ja det är sant — och det är just med avseende å dessa fördelar, som jag skall be att få yttra några ord. Om kammaren nu avslår lagförslaget, komma vi fortfarande att få dragas med de gamla otillfredsställande bestämmelserna i 1853 års reglemente.

I avseende å de stora förbättringar, som lagförslaget upptager, synes det mig särskilt vara värt uppmärksamhet, att man framflyttat ympningsåldern för barn till 6 år. Detta är en mycket betydelsefull sak, särskilt därför att man under de första levnadsåren har att räkna med en stor barnadödlighet, som man i viss mån skrivit på vaccinationens konto, ehuru den i regeln har helt andra orsaker. Därigenom att man framflyttat åldern på detta sätt, har man överfört vaccinationstvånget till. en tidpunkt, då barnen i regel äro på ett helt annat sätt motståndskraftiga än under de två första levnadsåren. Om verkningarna av en likartad bestämmelse i Danmark har man uteslutande förmånlig erfarenhet. Det har inom utskottet upplysts, att man i Danmark funnit framflyttningen av åldern för vaccinationens verkställande till inom det 7:e levnadsåret synnerligen lyckligt, och att det icke möter några svårigheter eller avsevärda risker att vid den tidpunkten verkställa ympning av barnen.

Vidare ha vi också i utskottet närmare förtydligat och utvecklat Kungl. Maj:ts förslag med avseende å befrielse från ympning för sjukdom. Utskottet har sålunda föreslagit, att vederbörande ympare — vare sig denna är läkare eller särskild ympare (**barnmorska**[3]) — kan på ympningseller besiktningsmöte eller eljest vid företagen undersökning från ympning undantaga person, som ymparen finner »till följd av sjukdom eller sjukdomsanlag eller allmän svaghet kunna komma att erhålla men av ympningen». Därigenom har man också velat gardera sig för att, om barnet är klent och svagt, utan att lida av direkt sjukdom, ett uppskov med ympning kan äga rum. Ett sådant undantagande gäller för ett år i sänder. Det är en mycket viktig omständighet, att man på detta sätt kan få ympningen framflyttad och förlagd till den för barnens hälsotillstånd mest gynnsamma tidpunkten.

Ytterligare blir praktiskt taget, all ympning avgiftsfri för dem ympade. Detta innebär en

mycket stor fördel, då ju därmed genom

ympningen icke påläggas några utgifter för den enskilda. Ej heller drabbas landskommunerna av några utgifter för skyddskoppympningens anordnande, i det att utskottet, med biträdande av en av herr Olausson väckt motion, föreslagit, att staten skall ikläda sig alla kostnader för ympning på landsbygden, således för resor till ympningsmöte ävensom för det arvode, som för varje person skall utgå till ymparen. Detta är således en obestridlig fördel till lättnad för vederdbörande kommuner och en avsevärd förbättring av nu gällande förhållanden.

Vidare har man i utskottet gjort den utvidgning av förslaget i avseende å frågan om vem, som skall vara ympare, att man, såframt ej sörskilda undantag medgivas, föreslagit, att tjänsteläkaren skall vara pliktig att vara ympare inom hela sitt distrikt. Nu är det uppenbart, att det i vidsträckta distrikt, särskilt i Norrland icke är möjligt att låta tjänsteläkaren bli ympare för alla socknar i distriktet, men i det övervägande antalet socknar kommer han säkerligen att kunna verkställa ympning. Och detta på statens bekostnad. Vid dessa förhållanden vinner befolkningen i de trakter, där tjänsteläkaren blir ympare, också den fördelen, att den vid flera tillfällen än eljest får möjlighet att få läkaren upp till sig och därigenom kan anlita honom icke blott för ympning, som det närmast är fråga om, utan för läkarvård i allmänhet. Jag tror, att detta likaledes är en betydelsefull omständighet att fästa avseende vid. Ytterligare en annan sak av vikt: man har inom utskottet föreslagit inrättande av en särskild institution, särskilda »besiktigare» i och för den besiktning av den ympade, som skall efterfölja en ympning. Härmed har man åsyftat dels att lindra kostnaderna för det allmänna, dels också att möjliggöra, att läkaren, såvida det är fråga om en tjänsteläkare, kan vara ympare i större omfattning än eljest bleve möjligt. Utskottet har därför upptagit förslag om antagande, efter vederbörligt medgivande av dylika särskilda besiktigare, för vilka skulle erfordras samma kompetens som för särskilda ympare.

Så har man slutligen den stora förbättringen med animalt ympningsämne, såsom en nästan undantagslös regel, ett ympämne. som skall kostnadsfritt tillhandahållas, och som, såvitt utskottets ledamöter funnit, beredes under den största och noggrannaste kontroll och därför måste betraktas som absolut ofarligt.

Dessa nu antydda omständigheter måste man beakta. när man tager ställning till föreliggande lagförslag.

Till vad jag sagt skulle jag vilja foga ytterligare ett par ord angående ympning vid epidemier, som från några håll anförts böra ersätta barnvaccineringen. Härvid bör dock uppmärksammas den långa inkubationstiden av 10—14 dagar vid smittkoppor, ävensom den ofantliga smittofarligheten och den omständigheten att en person är smittobärare såväl före utslagets utbrytande som efter det utslaget intorkat. Denna långa inkubationstid gör, att personer, som äro smittade, kunna, till synes friska, gå omkring och därigenom också förorsaka att andra smittas. Det bör härvid även uppmärksammas, att något skydd icke lämnas av yrapningen

förrän 4 dagar förflutit

före denna tid. Endast om det förflutit längre tid än 4 dagar mellan vaccinationen och smittan, blir kroppen immun men blott delvis; immuniteten växer sedan intill nionde dyget, då full immunitet mot smittkoppsmitta inträder.

Jag har velat göra dessa kompletterande erinringar i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, man vill icke längre upptaga kammarens strängt anlitade tid, då ju för övrigt redan så mycket blivit sagt i denna fråga.

Jag ber i anslutning till vad jag har yttrat att få yrka bifall till föreliggande paragraf av lagförslaget.

5. Värner Ryden (Socialdemokraterna, man)

Herr talman, mina herrar! Beträffande den här föreliggande frågan står jag personligen på den ståndpunkten, att en vaccinationslag bör finnas, men den bör inrymma en bestämmelse, som medgiver och möjliggör för sådana föräldrar, som lida av verklig samvetsnöd, när det gäller att överlämna deras barn åt vaccinatören, att bli befriade från vaccinationstvånget. Ur den synpunkten hade jag den förhoppningen, när detta särskilda utskott tillsattes, att man inom detsamma skulle ägna något mera uppmärksamhet åt den motion, som herr Bernhard Eriksson väckt och som avsåg att finna en form för att lösa denna fråga. Emellertid har utskottet 1 stället för att ta hänsyn till den mening, som man visste omfattades av många här i kammaren, gått på den linjen att framlägga ett lagförslag, som i allt väsentligt innebär en skärpning av de bestämmelser, som nu finnas.

Det är visserligen sant, att detta lagförslag ur snygghetens och hygienens synpunkt bjuder fördelar framför det nuvarande. Men i det avseende jag nu berört innebär det en skärpning av nuvarande bestämmelser i stället för en lindring av desamma i enlighet med riksdagens därom gjorda framställning.

Hade det nu varit vid en tidpunkt på riksdagen, då man haft ett par veckor kvar och haft kammarens ledamöter samlade, så skulle jag för min del ha röstat för bifall till första paragrafen i lagförslaget, men ifråga om andra paragrafen däremot framställt ett yrkande om samvetsklausul. Men nu har jag genom samtal med medlemmar av utskottet kommit till den bestämda uppfattningen, att om kammaren här skulle gå den vägen att bifalla $ 1, men i 8 2 taga exempelvis den reservation, som avgivits av herrar Hult och Vennerström, så kommer utskottets sammanjämkningsförslag med all säkerhet att bara så tillvida innebära ett medgivande åt en sådan mening i andra kammaren, att man höjer åldersgränsen från vad första kammaren beslutat, nämligen två år, till sex år, som utskottets förslag innehåller. Ja, vi äro bortresta, då detta sammanjämkningsförslag skulle komma före, och det är ovisst, hur det kan komma att gå därmed, när det kommer till kamrarna efter pingst. Under sådana förhållanden blir, om vi bifalla 1 $ och sedan taga 2 $ i enlighet med den Vennerströmska reservationen, resultatet, såvitt jag kan förstå, att vi få lagen, sådan den finnes i utskottets

betänkande. Och det får jag

säga, att i valet mellan att få frågan uppskjuten till nästa år och då få fram ett lagförslag i tid samt vinna något gehör för den mening, som har stark anslutning här i kammaren, och å andra sidan att få lagförslaget igenom i denna form, som man icke kan acceptera, står det klart för mig, att man icke har någon annan utväg än att rösta för rent avslag i år. Men det innebär då för mitt vidkommande, att Jag ett annat år kommer att företräda den uppfattning, som jag här glort mig till tolk för. : .

Jag skulle till dem, som starkt hålla på vaccinationen, och som här med skicklighet lagt debatten så, som vore det fråga om antivaccination eller vaccination — och särskilt har ju min ärade kamrat på Malmöbänken med stor skicklighet och bravur gisslat alla överdrifter 1 antivaccinationslitteraturen — samt lagt debatten så, att man skymmer undan det, som efter min uppfattning är det vitala och centrala härvidlag — jag skulle till dem, som vilja ha en fullständigt undantagslös tvångsvaccination, rikta det spörsmålet, om det ändå är riktigt, att vi i vår tid med den begränsning, som man lyckats giva faran för smittkopporna, skapa martyrer i landet genom en sådan lag. Jag fäster mig därvidlag icke alls vid de grupper, som äro uppagiterade, men man skall alldeles trampa sanningen under fötterna, om man vill förneka, att det dock förekommer fall av samvetsbetänkligheter beträffande vaccinationen, som icke kunna skrivas bara på agitationens och fanatismens konto. Jag känner personligen ett fall i en upplyst familj, där man haft ett barn, som från och med vaccinationen fått ohälsa och efter ständig ohälsa dött vid en ung ålder. Det är möjligt, det kan jag icke bedöma, att läkarna kunna absolut konstatera, att ett sådant sjukdomsfall, låt vara att det begynt i samband med vaccinationen, icke framkallats av denna. Men är det underligt, om den familj, som sett ett barn på detta sätt komma till ohälsa, under sådana förhållanden är övertygad för sin del, att sjukdomen har kommit på grund av vaccinationen? Är det underligt, om dessa föräldrar, ifall fråga uppstår om att vaccinera flera medlemmar av familjen, för sin del säga: vi taga hellre straffet än utlämna våra barn åt denna risk. Nu kommer denna lag med upprepade bötesbestämmelser, som för de fattiga medföra, att de bli kastade i fängelse. Jag tror för min del icke, att de som hålla på vaccinationstvånget göra rätt. då de hålla på att detta tvång skall upprätthållas på detta sätt och vilja skapa en lag, som icke medgiver undantag ens för sådana fall, där man kan säga, att man ytterst straffar föräldrakärleken.

På grund av dessa skäl måste jag i första paragrafen biträda yrkandet om avslag.

6. Carl Persson (Lantmanna- och borgarepartiet inom andrakammaren, man)

Herr talman! Jag skall be att med några ord få angiva min enskilda ståndpunkt i denna fråga. : Alla äro väl ense därom, att det nu föreliggande förslaget

innebär införandet av betydligt strängare bestämmelser än de nu gällande. Av redogörelsen i Kungl. Maj:ts proposition framgår ju också, att försök flera gånger ha varit å bane inom riksdagen att få strängare bestämmelser i detta avseende, men att de ständigt ha avvisats av

denna kammare. När det förhåller sig så, att även det föreliggande förslaget innebär en skärpning av bestämmelserna, så får jag säga, att det skulle förefalla mig bra märkvärdigt, om denna kammare skulle gå ifrån den uppfattning i detta avseende, som den förut haft, nämligen att den vill ha något mildare bestämmelser. Jag vet sannerligen icke, vad har inträffat som gör, att man nu här skulle foga sig i att utan vidare antaga ett sådant förslag. Om frågan här gällde för eller emot vaccinationen, om det gällde ett upphävande av de bestämmelser, som nu finnas, ja, då får jag säga, att jag för min del skulle vara tveksam, hur jag skulle ställa mig, eller, jag kan säga, att jag då skulle bestämt avgiva min röst för att icke upphäva de bestämmelser, som nu finnas, utan för deras bibehållande. Härmed har jag sålunda tillkännagivit, att jag är för vaccinationen. Detta kan jag också styrka därmed, att jag icke det ringaste tvekat att låta vaccinera dem, som jag varit målsman för, utan villigt fogat mig i bestämmelserna.

Men oaktat jag har denna uppfattning, så är det naturligt, att jag också måste ge dem rätt, som ha en annan mening, nämligen att de vilja ha dessa bestämmelser något mildare. Jag tror också, att dessa genom den kungl. propositionen och den utredning, som skett i frågan, ha fått ett så starkt stöd för sin åsikt, att man icke kan utan vidare avvisa dem. Om nu detta stöd komme endast från den olärde mannen, så skulle jag icke fästa så mycket avseende därvid, men detta stöd kommer också från vetenskapsmän, som stå lika högt i vetenskaplig insikt, som de, som förfäkta de strängare bestämmelserna. Utredningen visar ju, att det finns framstående läkare och vetenskapsmän, som ha en mot majoriteten i sin kår motsatt uppfattning, och undra då på, att de, som arbeta på att få bort tvångsvaccinationen, däri finna ett mycket verksamt stöd.

Jag skall icke upptaga tiden med att andraga några sådana fall, men det är ingen möjlighet att underlåta att uppläsa en enda passus i medicinalstyrelsens utlåtande, som finnes anförd i den kungliga propositionen, där medicinalstyrelsen talar om de faror och olägenheter, som stundom visa sig efter utförda ympningar. Jag vill påpeka detta nu, därför att dessa samvetsömma häruti få ett stöd för sin uppfattning, att de icke vilja låta tvinga sig till att släppa till sina barn till detta offer. Det är icke underligt, om de bliva ännu mera motvilliga härtill, då de läsa sådant, som här anföres av medicinalstyrelsen på sidan 25 i den kungliga propositionen. Det heter där: »Den ympade själv kan genom egen eller omgivningens ovarsamhet föranleda en del obehag. Genom attt. ex. riva sönder kopporna med fingrarna kan han medelst dem överföra lymfa till andra delar av kroppen och

sålunda framkalla koppor å icke avsedda ställen; om härvid ömtåligare delar, såsom de **kvinn liga**[1] könsorganen, men än mera ögonen, bliva säte för koppor, kunna obehag och någon gång faror inträffa. Koppor på ögonlocken kunna sålunda bliva åtminstone besvärliga nog och om hornhinnan angripes, kan kvarstående men bliva följden i form av nedsatt synförmåga; enstaka fall äro även kända, då synförmågan alldeles förstörts.» Det är nu medicinalstyrelsen, som trots att den vill ha denna strängare bestämmelse, säger sådant. Jag undrar då, om icke dessa samvetsömma häri få ett mycket, mycket starkt stöd för sin uppfattning att icke släppa

till sina barn till dessa offer. Sedan följer »läkarerfarenheter i Sverige», och där har man icke mindre att anföra rörande dessa överföringar. Det säges där bland annat: »Beträffande denna redogörelse får jag, i övrigt hänvisande till medicinalstyrelsens betänkande i förevarande del, allenast omförmäla, att i 2 fall möjlighet ansetts föreligga, att barnförlamning överförts genom ympning, att i 1 fall överföring av syfilis genom ympning med humaniserad lymfa ansetts sannolik, att i 1 fall lungsjukdom ansetts vara en följd av ympning samt att uppgifter dedeutom lämnats om ett eller annat fall av eksem eller liknande utslag i följd av ympning.» Detta lilla korta sammandrag visar ju, att det är helt naturligt, att det kan kännas mycket svårt för dem, som äro emot vaccinationen, att släppa till dessa offer. Men nu är det dessa vetenskapsmän, som lämna sådana intyg. Tänk nu om alla de, som icke äro vetenskapsmän, men som gjort iakttagelser i livet på detta område, skulle framdraga sina exempel. Då bleve det säkerligen någonting hårresande. Men detta skulle ju icke ha något värde, därför att dessa personer icke fått något betyg av vetenskapsmännen på riktigheten av sina iakttagelser.

är kunde vara mycket att säga, men jag skall icke nu uppehålla tiden. Jag ber dock att få säga som slutkläm, att det skulle vara mycket märkvärdigt, om andra kammaren, som vill ta de samvetsömma i försvar, ja, som gått så långt, att den, då en yngling på tjugu år icke vill taga på sig militär uniform, vill fritaga honom därifrån, på grund av att detta skulle strida mot hans samvete, här skulle utan hänsyn till samvetsbetänkligheter tvinga föräldrar att släppa till det käraste de ha, deras barn, att undergå denna tortyr, varigenom de möjligtvis kunna bliva ett offer Bland dem, som här uppräknats. Även på dessa måste vi tänka, då vi ju äro ombud för hela den svenska befolkningen.

Vi leva ju i en tid, som räknar sig som frisinnets. Är det då skäl i att på detta sätt införa ännu strängare tvångslagar än vi äga? Jag kan icke finna det. Och för övrigt, de lagar, som vi ha, äro ju så verksamma, vilket framgår av statistiken, som utdelats, att ingen nämnvärd fara förefinnes, om de efterlevas.

Då jag således yrkar avslag, så har detta icke sin grund

det förelivennde, vilket innebär betydligt skärpta bestämmelser på ett område, där man i stället väntat att få något mildare. Om förslaget nu faller, så äro ju fortfarande de nuvarande bestämmelserna gällande, och ingen skada är alltså skedd genom ett avslag på utskottets förslag, som alltså utgör mitt yrkande.